

F

特発性肺血鉄症

idiopathic pulmonary hemosiderosis (IPH)

到達目標

- ◆ 肺胞出血をきたす疾患の鑑別ができる
- ◆ 特発性肺血鉄症の画像を説明できる
- ◆ 特発性肺血鉄症の症状が説明できる

病因・病態・疫学

特発性肺血鉄症は、原因不明の肺胞出血を繰り返す



図1 特発性肺血鉄症の胸部X線写真（14歳男児）
1カ月前から咳嗽、血痰があり来院した。RBC $204 \times 10^4/\mu\text{L}$ 、Hb 4.6 g/dL、Ht 14.3%と貧血を認めた。胸部X線写真では両側びまん性に斑状影を呈した。

症候・身体所見

繰り返す肺胞出血により、咳嗽、血痰や咯血、呼吸困難、発熱、チアノーゼ、貧血に伴う全身倦怠感や動悸などの症状がみられる。進行例ではバチ指を呈する。呼吸器症状が乏しく、貧血のみで発症する症例もある。

診断・検査

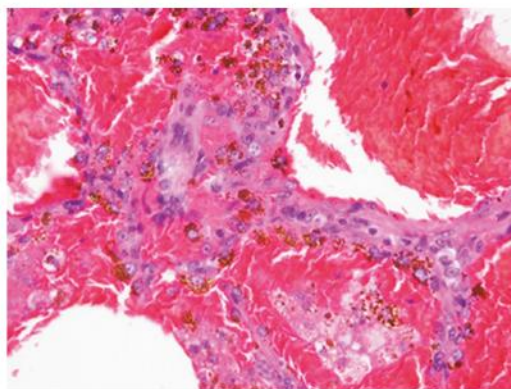
繰り返すびまん性肺胞出血とそれに伴う症状がある症例において、肺胞出血をきたすような血管炎、膠原病、肺高血圧症などの全身疾患を鑑別、除外することが重要である。

血液生化学検査では、鉄欠乏性貧血がみられ、KL-6が上昇することもある。胸部画像所見は、肺胞出血による非区域性の肺胞性陰影、斑状影、すりガラス影などを呈する（図1、図2a）。

気管支肺胞洗浄や肺組織で赤血球やヘモジデリンを貪食したマクロファージを認めることが肺胞出血の証明となり、前述の全身疾患の除外と併せて、本症と診断される（図2b）。



a.



b.

図2 同一症例の胸部CT（a）および開胸肺生検による肺組織像（b）

a：境界が不明瞭な肺胞性陰影を呈した。

b：肺胞内に赤血球とヘモジデリン貪食細胞を多数認めた。